

PENYAKIT KEPALA LEHER

Fistula dan kista brankial

Higroma kistik

Tortikolis

Abses Bezold

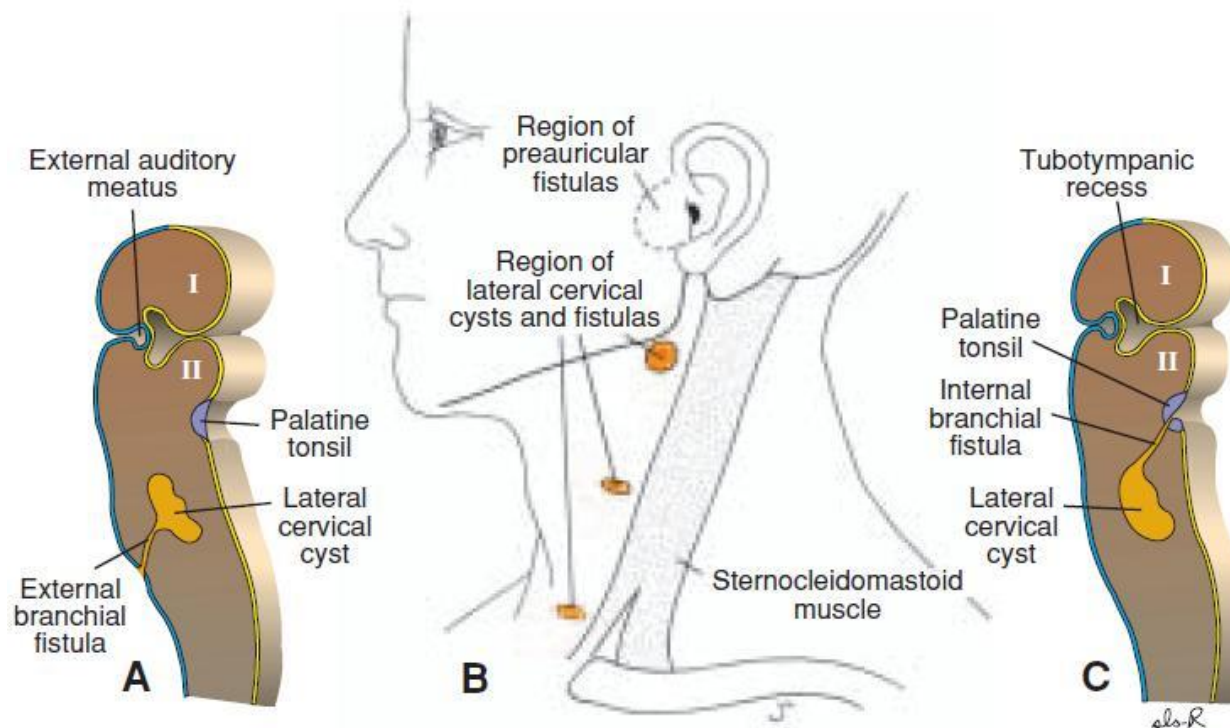
Mastoiditis

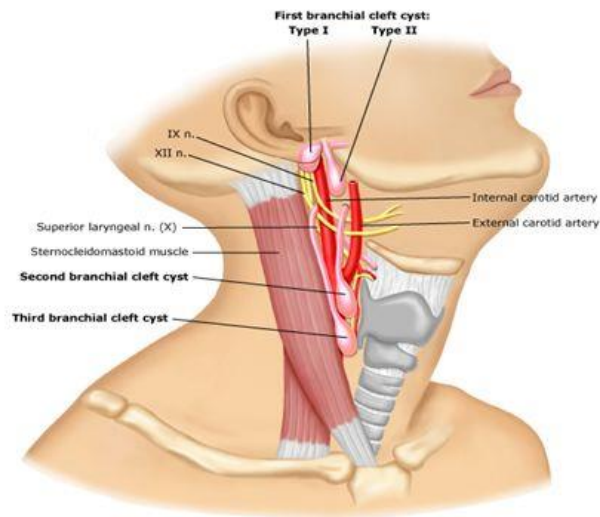
Fistula dan Kista brankial

Definisi

- Fistula dan kista brankial atau lesi servikal lateral → defek perkembangan kongenital yang berasal dari aparatus brankial

Patogenesis





**BRANCHIAL CLEFT
'CYSTS' (FISTULAE) - often
have tracts that extend from
site of embryological origin**

POUCH	FORMS	CLINICAL
First	1) Auditory tube 2) Tympanic cavity	First Branchial 'Cleft' cyst - tract linked to external auditory meatus
Second	Lining (crypts) of palatine tonsils	Second Branchial 'Cleft' cyst - tract linked to tonsillar fossa (palatine tonsils) - MOST COMMON CYST
Third	1) Inferior parathyroid gland 2) Thymus	Third Branchial 'Cleft' cyst - tract at thyrohyoid membrane or piriform recess
Fourth	1) Superior parathyroid gland 2) C-cells of Thyroid	rare

Manifestasi klinis



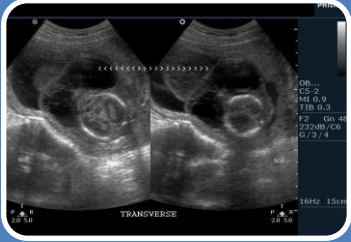
Figure 1 Branchial cleft cyst in the neck





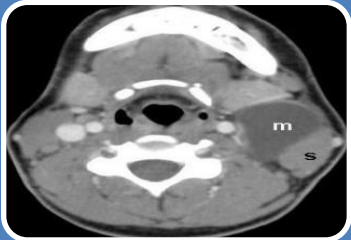
Figure 1: A complete branchial fistula of the right side and a branchial sinus on the left side.

Diagnosis



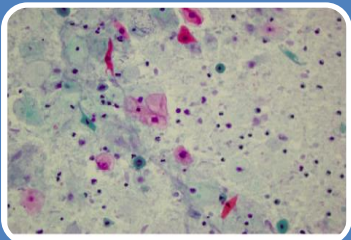
Ultrasonografi

- Massa berbatas tegas dengan isi yang homogen tak bersepta biasanya muara fistel tidak dapat diidentifikasi



Tomografi komputer

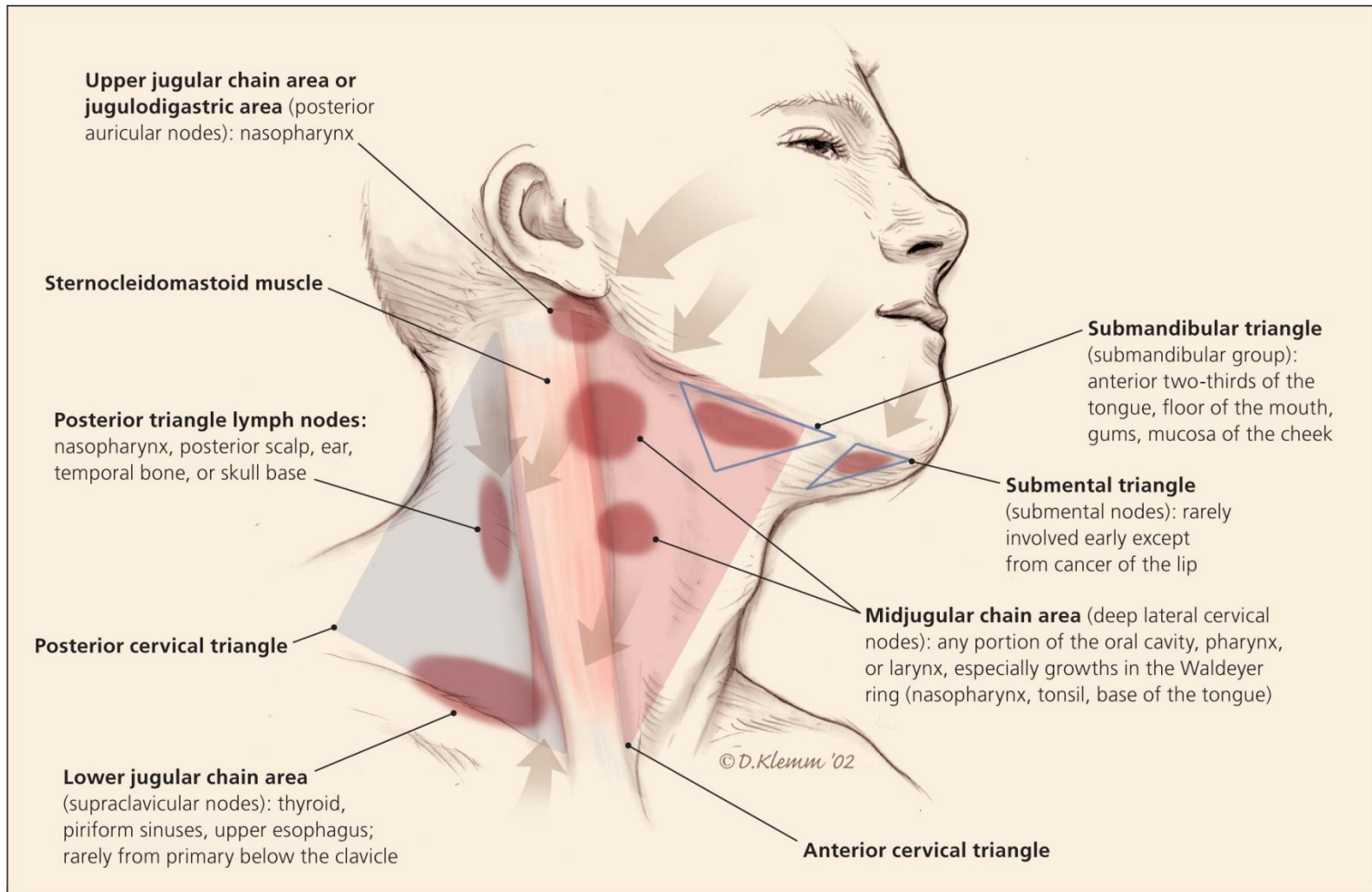
- Massa kistik yang menyerap kontras



Biopsi jarum halus

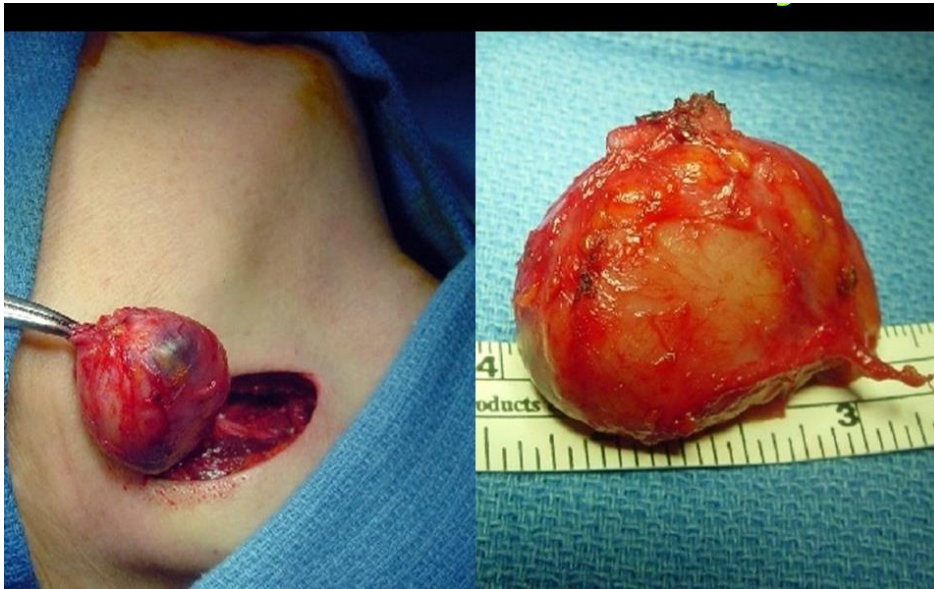
- Sel sel berkeratin tidak berinti
- Sel sel epitel skuamosa dengan maturitas yang bervariasi

Diagnosis Banding



Penatalaksanaan

- Terapi Definitif → bedah (eksisi)
- Bila infeksi → tunda, antibiotik, insisi drainase.



Komplikasi

- Tidak ditangani → infeksi dan pembentukan abses rekuren, pembentukan skar, kelainan struktur lokal
- Komplikasi terapi bedah → rekurensi, pembentukan fistula persisten dan kerusakan nervus kranialis
- Prognosis
- Jarang → maligna

Kista Higroma Colli

- Kelainan kongenital akibat defek dari sistem limfatik yang bermanifestasi sebagai lesi jinak, lunak dan tidak nyeri
- 75-80% lesi terjadi di kepala leher, 20% aksilla, dan 5% mediastinum
- 1 kasus pada 6000-16.000 kelahiran
- 50-60% ditemukan saat lahir
- Laki-laki= perempuan

Etiologi

Lingkungan

- Infeksi parvovirus
- *Maternal substance abuse*

Genetik

- Abnormalitas kromosom sex pada wanita → sind. Turner
- Trisome 13,18,21

Idiopatik

- unknown

Gambaran Klinik



- Benjolan leher, kistik, lunak, permukaan halus, *mobile*, berbatas tegas.
- Kebanyakan pada reg trigonum posterior colli
- Transiluminasi tampak terang

Diagnosis

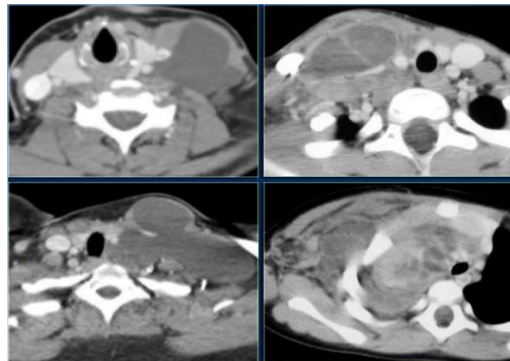
USG

- Kista tunggal/multipel
- Tidak ada aliran darah
- Bersepta



TK

- Kista tunggal
- Homogen
- Batas tegas
- Tidak invasi



MRI

- Menilai sejauh mana infiltrasi ke struktur lainnya



Klasifikasi

Mulliken & Glowacki

- Hemangioma dan malformasi vaskuler

Kriteria WHO

- 3 Tipe limfangioma → kapiler, kavernosa dan kista

Giguere

- Berdasarkan ukuran komponen → >2 cm makrokista, < 2 cm mikrokista, dan campuran

De Serres

- Sistem staging → stadium I, II, III, IV dan V

Diagnosis Banding

- Kista celah brankial
- Kista duktus tiroglosus

Penatalaksanaan

- Eksisi komplit
- *Sclerosant agent*
- Drainase, aspirasi, radiasi, eksisi dengan laser, ablasi dengan radiofrekuensi → hasil yang bervariasi
- Skleroterapi dengan bleomycin intralesi

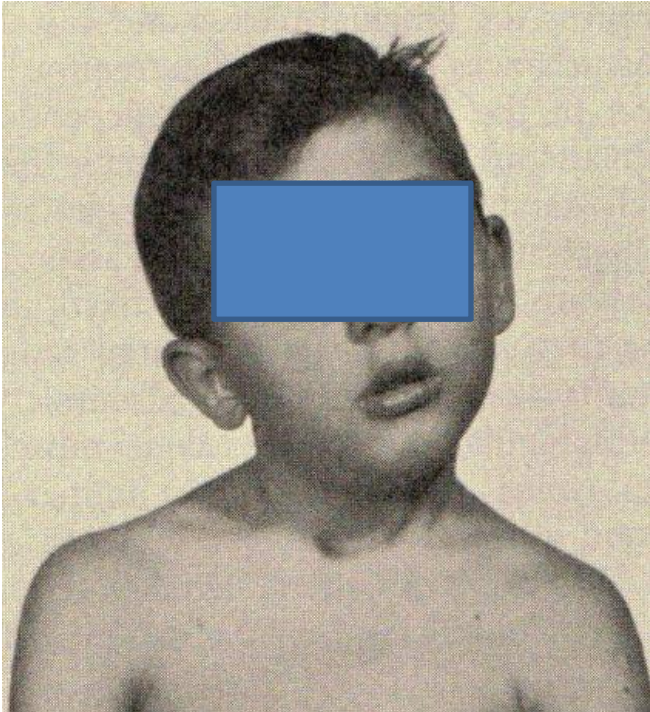
Komplikasi

- Infeksi dari respiratory tract
- Perdarahan spontan, ruptur spontan
- Sumbatan jalan napas
- disfagia

Tortikolis

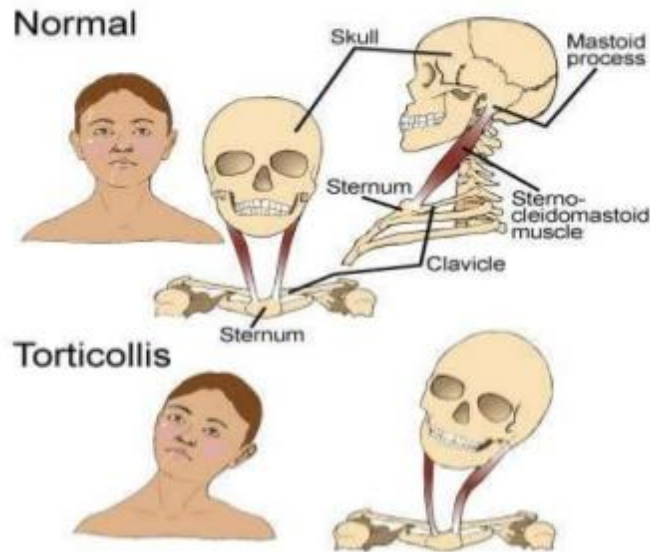
- Kekakuan leher yang menimbulkan spasme otot → leher bengkok atau terputar
- Berasal dari bahasa latin, *torus* (bengkok), *colli* (leher)
- Bukan diagnosis, tp kumpulan gejala
- Diklasifikasikan → kongenital, dapatan, spasmodik

Definisi



- Kepala berada pada posisi miring, dengan dagu menunjuk kea salah satu bahu, sedang kepala miring ke arah bahu yang berlawanan → rotasi leher

Etiologi dan Patofisiologi



- Gangguan m. SCM
- Pada bayi → pada saat proses persalinan atau posisi bayi dalam rahim
- Pada anak → trauma otot, infeksi dan penyebab lain

- Menurut Freed dan Colleen → pada anak tdp 3 tipe

Tipe oseus

- Disfungsi osipitoservikal
- Disfungsi vertebraservikal (sind. Klippel-Feil)
- hemivertebra

Tipe non oseus

- Tortikolis muskular kongenital

Tipe neurogenik

- Tumor pd SP
- Sind. Sandifer
- Malformasi Arnold chiari
- Tortikolis okular
- Tortikolis paroksismal

Manifestasi Klinik

- Rotasi leher (*turn and tilt*) 75% pada sisi kanan
- Spasme otot leher dan punggung
- Keterbatasan lingkup gerak sendi
- Dapat ditemukan tumor leher
- Tortikolis muskular kongenital dapat ringan-berat

Diagnosis

- Riw. Persalinan dan PF → kongenital atau dapatan, trauma atau nontrauma
- PF → keterbatasan LGS
- Radiologi → foto polos servikal, TK, MR



Diagnosis Banding

- Tortikolis dapatan
- Sindroma Klippel- Feil → fusi/berkurangnya jumlah vertebra cervical, *low hair line*, gerakan leher terbatas
- Atlanto aksial rotator subluksasi

Prognosis

- Dubia

Tatalaksana

Non farmakologis

- Fisioterapi
- Terapi okupasi
- Ortotik prostetik

Farmakologis

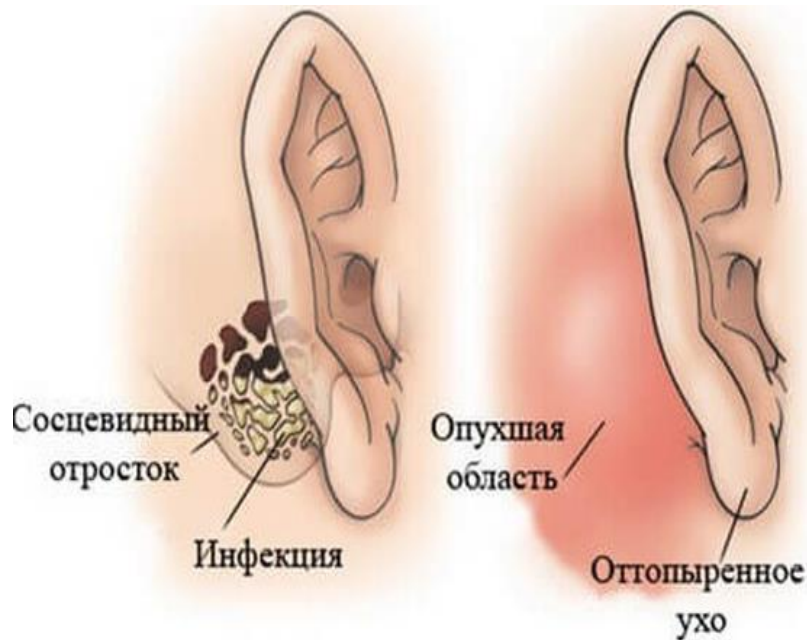
- Injeksi toksin botulinum

Pembedahan

- Tenotomy

ABSES BEZOLD

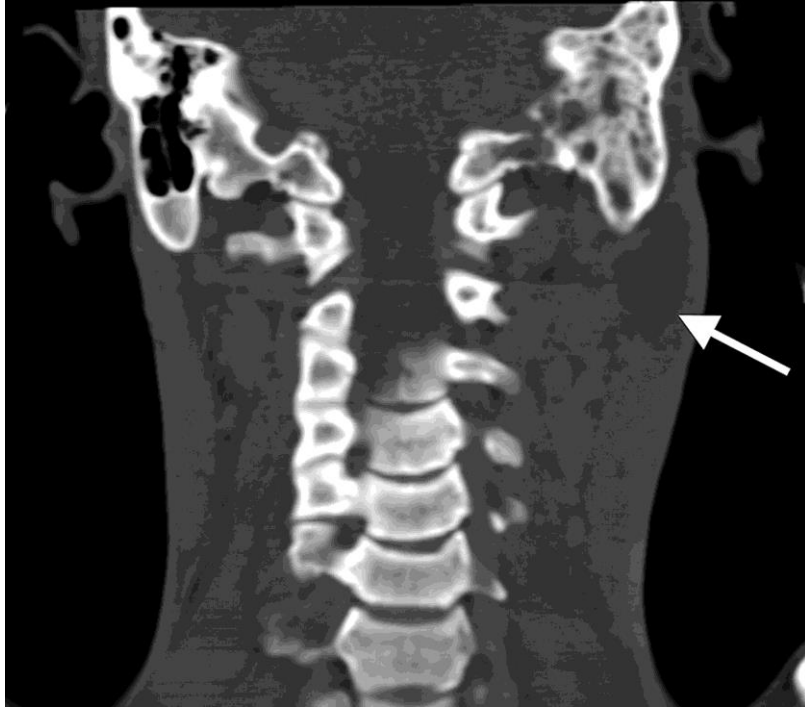
Merupakan abses pada bagian medial m. SCM dimana pus berasal dari korteks mastoid dari tulang temporal, turun ke perlekatan bagian medial SCM hingga ke fossa infratemporal → komplikasi jarang pada otitis media



Gejala

- Nyeri di bagian perimastoid
- Disfagia
- Nyeri tenggorok
- Dispneu
- Kaku leher
- Demam

Diagnosis



- CT Scan mastoid

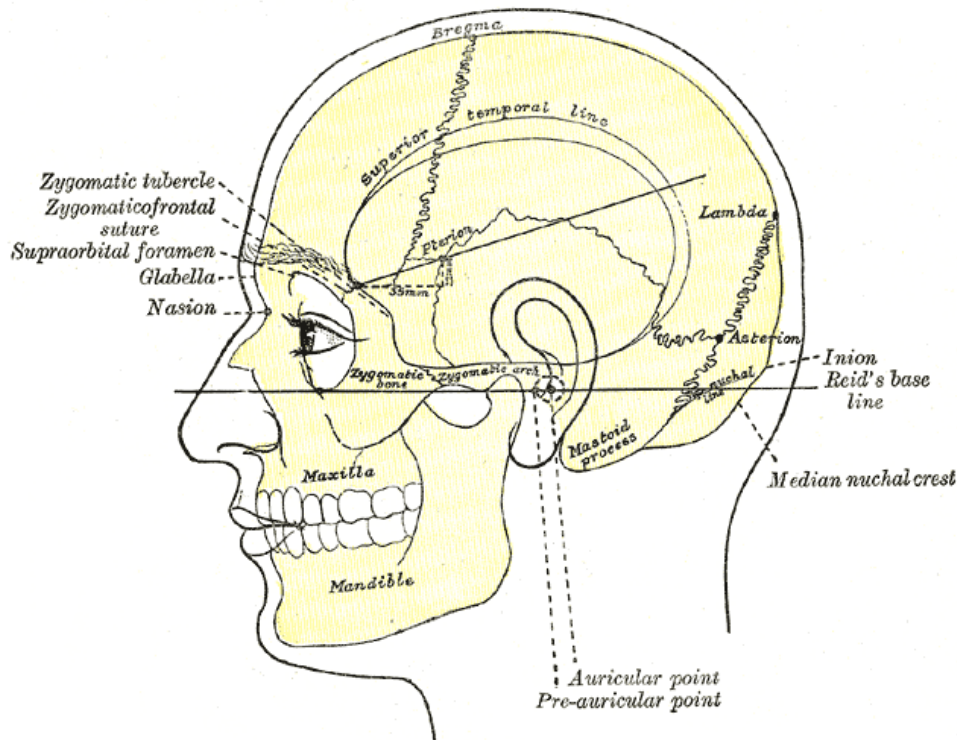
Diagnosis Banding

- Limfadenitis
- Abses atau massa parotis
- Kista brankial terinfeksi
- Trombosis vena jugular
- Abses parafaring

Tatalaksana

- Mastoidektomi → eradikasi fokus infeksi
- Insisi drainase abses
- Antibiotik → kultur dan resistensi

MASTOIDITIS



- Infeksi pada tulang mastoid → komplikasi dari otitis media
- Antibiotik → jarang

Etiologi

- Usia
- Sosial ekonomi
- Virulensi
- Imunokompramais
- kolesteatom

Patofisiologi

Aditus ad antrum tersumbat



Terjadi eksudasi pada sel mastoid yang tidak terdrainase → simple mastoiditis



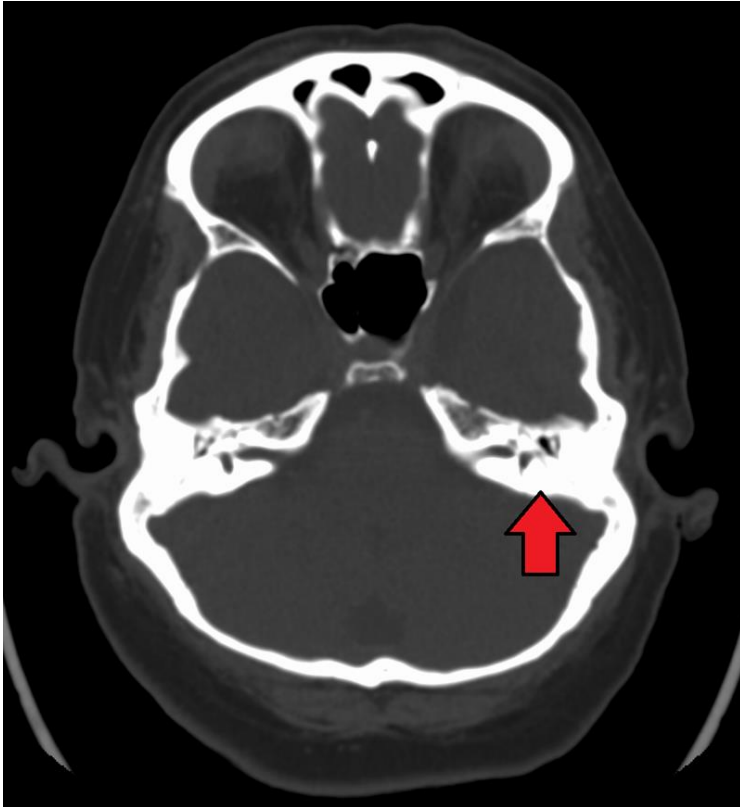
Demineralisasi septa mastoid dan pembentukan kavitas yang berisi pus

Gejala dan Tanda



- Daerah mastoid yang bengkak, nyeri dan lunak pada perabaan.
- Otalgia
- Demam, nyeri kepala
- Otore
- Pada bayi disertai gejala nonspesifik spt anorexia, diare

Diagnosis



- Anamnesis dan pemeriksaan fisik
- Radiologi → CT Scan, MRI

Tatalaksana

- Pada era antibiotik → menurunkan angka kejadian dan mencegah progresifitas penyakit
- Prosedur bedah mulai dari miringotomi hingga mastoidektomi

Prognosis

- Terapi yang adekuat → baik
- Terapi tidak adekuat → komplikasi
 - *Hearing loss*
 - Labirinitis → vertigo
 - Paresis fasialis
 - Abses bezold
 - Abses subperiosteal, meningitis, abses epidural, tromboflebitis, brain abscess

TERIMAKASIH